

First Stage of Labor & Perineal Care

المرحلة الأولى من الولادة والعناية بالعجان

Management of the first stage of labor (23 steps) + Perineal care procedure

إدارة المرحلة الأولى من الولادة + إجراء العناية بالعجان خطوة بخطوة

How to read this file: English on the left, Arabic on the right. **Bold** = important keyword. Yellow box = the reason (Why). Last pages = exam summary.

اليمين. الخط الغامق = كلمة مهمة. المربع الأصفر = السبب (ليه؟). آخر الصفحات = ملخص الامتحان.

1. First Stage of Labor

Definition

First stage of labor starts from the **true labor pain** and ends with **full cervical dilation (10 cm)**.

It is the **longest** stage and has **3 phases**: Latent, Active, Transition.

وتنتهي لما عنق الرحم يفتح كامل (10 سم).
Latent والنشط ((Active والانتقالي ((Transition.

Primipara = a woman giving birth for the **first time**.

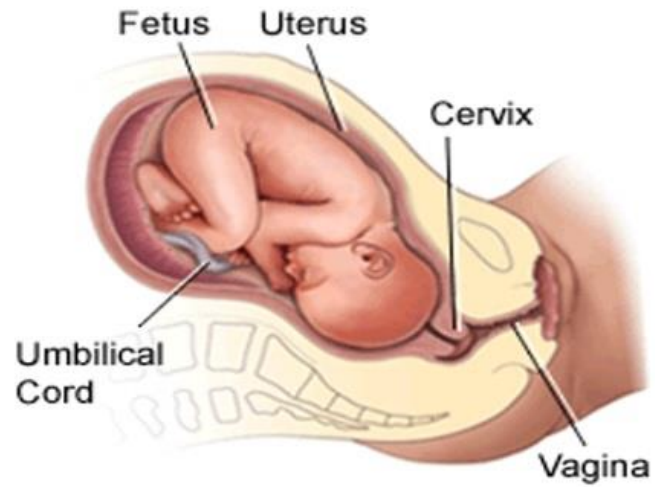
Multipara = a woman who has given birth **more than once**.

Phase الطور	Latent الكامن	Active النشط	
Cervical dilation فتحة عنق الرحم	0–3 cm	4–7 cm	
Duration: Primipara المدة: أول ولادة	6–8 hours	3–5 hours	
Duration: Multipara المدة: ولادة متكررة	3–5 hours	1–2 hours	
Contraction intensity قوة الانقباض	Mild خفيف	Moderate to strong متوسط لقوي	
Contraction duration مدة الانقباض	15–30 sec	30–60 sec	
Frequency (per 10 min) التكرار (كل 10 دقائق)	1–2	3–4	
Interval between contractions الفاصل بين الانقباضات	5–10 min	3–5 min	

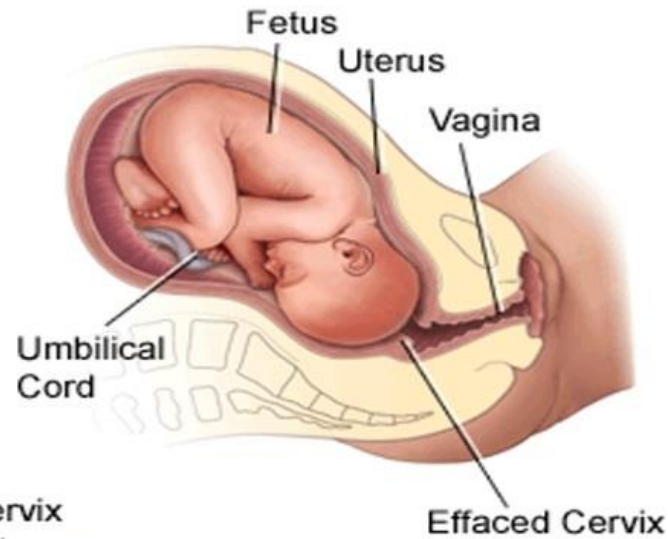
Remember: Transition is the **hardest** but the **shortest** phase.

اتذكر: الطور الانتقالي هو الأصعب لكنه الأقصر.

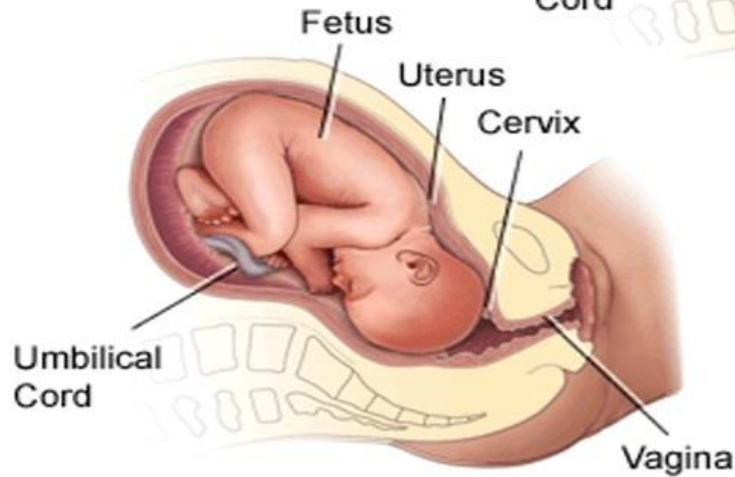
Initial (Latent) Phase **Stage 1**



Active Phase



Transition Phase



Stage 1: latent, active and transition phases

المرحلة الأولى: الطور الكامن والنشط والانتقالي

2. Preparation & Equipment

2. التحضير والأدوات

Equipment for first-stage management	
Vital signs set Sphygmomanometer, thermometer, stethoscope, watch	مقياس ضغط الدم، ميزان الحرارة، سماعة، ساعة
F.H.R. monitoring set (Fetal Heart Rate) Pinard or Sonicaid, C.T.G.	سماعة الجنين، Sonicaid (دوبلر)، وجهاز C.T.G. (رسم قلب الجنين)
P.V. set (Per Vaginal exam) K.Y. gel, sterile or disposable gloves	هيلي (P.V.) جِل معقم أو يُستخدم مرة واحدة
Supplies Syringes, I.V. sets, cannulas (different sizes), sterile dressings, plaster, cotton, antiseptic solution, Foley or Nelaton catheter, urinary bags	إبر، مجموعات وريدية، كانيولات بأحجام مختلفة، شاش معقم، لاصق، قطن، مطهر، قسطرة Foley أو Nelaton، أكياس بول
Linens: gowns, towels	المرضى، فوط
Solutions Ringer, Ringer Lactate, Saline, Glucose	محال، ملح ((Saline)، جلوكوز
Enema set A clean, well-functioning enema with clamp	س ومعاها كلبس ((Clamp

Equipment for first-stage management	
Medication set Analgesics, antibiotics, antiemetic, uterotonic drugs	حيوية، مضاد للقيء، أدوية تقوية انقباض الرحم (Uterotonic)

3. Procedure: Management of 1st Stage

3. الإجراء: رعاية المرحلة الأولى

#	Step & explanation	
1	Admission - Greet the mother and explain the procedure. - Take informed consent. - Ensure privacy and confidentiality. Why: To control fear and anxiety.	.Inform ة.
2	Prepare the equipment Bring everything before starting (see equipment list). Why: To save time.	قائمة الأدوات).
3	Wash hands and wear gloves Why: To prevent infection.	

#	Step & explanation	
4	Take the history • Personal: name, age, address, education, duration of marriage. • Present: pregnancy symptoms, fetal movement, her feelings about pregnancy. • Medical: HTN, DM, cardiac diseases. • Obstetric: previous pregnancies (gravida, para, abortion, preterm or full term), details of them, mode of delivery, previous postpartum period, contraception, and LMP to calculate EDD. – LMP = Last Menstrual Period. EDD = Expected Date of Delivery. Why: Gives an accurate evaluation and detects any deviation from a normal pregnancy.	العنوان، التعليم، مدة الجواز. حركة الجنين، شعورها تجاه الحمل. سكر ((DM، أمراض القلب. Gravida حمل، Para ولادة، إجهاض، مبكر أو كامل)، تفاصيله، طريقة مع الحمل، وأول يوم في آخر دورة ((LMP لحساب موعد الولادة ((EDD. أي حاجة مختلفة عن الحمل الطبيعي.

#	Step & explanation	
5	Apply infection control • Use aseptic technique during the procedure. • Give dry and clean clothes and bed linen. • Change the pad often if discharge is excessive. • Do perineal care: on admission, before and after each vaginal exam, before delivery, before catheterization. Then cover the vulva with a sterile pad. Why: To prevent infection.	Aseptic technique تقنية كثيرة قبل، قبل وبعد كل فحص مهبل، قبل الولادة، وقبل القسطرة. وبعدها غطي

#	Step & explanation	
6	Is the woman really in labor? Look for these 6 signs: • Uterine contractions: ask when they began; assess frequency, intensity, duration within 10 min, every 30 min. • Show: blood-stained mucus discharge. • Membranes: ask about a gush of fluid. If unsure, use a tissue and smell it to exclude urine. If ruptured, record the time. • Frequent urination: caused by engagement; the presenting part presses on the bladder and reduces its capacity. • Cervical changes (by P.V. exam): shortening (effacement) and dilation. Slow in latent phase, progressive in active phase. • Formation of the bag of water.	6 علامات: تتبع، وقيّم التكرار والقوة والمدة خلال 10 دقائق، كل 30 دقيقة. دم. جأة. لو مش متأكدة استخدم منديل وشمه علشان تستبعد البول. لو الأغشية الجنين ((Engagement؛ الجزء المقدم يضغط على المثانة ويقلل المهبطي): قصر العنق ((Effacement وتفتحه. بطيء في الطور الكامن،

#	Step & explanation	
7	Take vital signs between contractions Check temperature, pulse, respiration and blood pressure when the uterus is relaxed. Why: To detect any abnormality.	وقت ما الرحم يكون مرتخي.
8	General examination Observe the general well-being of the mother.	
9	Local examination Abdominal (Leopold's manoeuvre) Inspection, palpation, auscultation. Vaginal / genital • Inspect for tenderness, swelling, discharge, ulcers, scars, lesions, inflammation, piles, monilial (fungal) infection (may lead to membrane rupture), HPV, swollen Bartholin's gland. • Assess: dilatation, effacement, station, moulding, engagement. – Effacement = thinning/shortening of the cervix. – Station = level of the fetal head compared with the ischial spines. – Moulding = overlapping of fetal skull bones. – Engagement = widest part of the head has entered the pelvis.	قروح، ندبات، التهاب، بواسير، عدوى فطرية ((Monilial) ممكن تسبب رم غدة بارثولين. قصر ((Effacement، مستوى الرأس ((Station، تشكل الجمجمة Engagen. نفق الرحم. بالنسبة للشوكة الإسكية ((Ischial spines. مة الجنين. في الرأس دخل الحوض.
10	Routine investigations • Urine: protein, glucose, pus cells, salts. • Blood: Hb%, RBCs, ABO and Rh. • Blood glucose level.	لحمراء، فصيلة الدم و Rh.

#	Step & explanation	
11	Follow the progress of labor Check cervical changes and uterine contractions regularly. Why: To monitor progression.	تنظيم.
12	Nutrition & hydration • Give frequent oral fluids: juice, soup, sweet tea. • Early labor: about 75 mL/hour fluids + digestive biscuits. • Give I.V. fluids if vomiting, ketosis, dehydration, or possible anaesthesia. • Keep an Intake & Output (I/O) chart. • Food: nutritious, easy to digest, small amount. • Avoid solid food during active labor. Why: Gastric emptying is delayed, so there is a risk of aspiration during anaesthesia. Fluids prevent dehydration and exhaustion.	ربة، شاي بسكر. وائل + بسكويت. كيتونات ((Ketosis أو جفاف، أو لو محتمل تخدير. يلة. ط. ((Aspiration لو اتعمل تخدير. والسوائل بتمنع الجفاف والإرهاق.

#	Step & explanation	
13	Rest, sleep & pain relief • Reassurance and support. • Hypnotics in the latent phase only if prescribed. • Warm nourishing drink helps her relax. • Quiet room, dim light, comfortable bed. • Ambulation (walking): may decrease need for analgesics, shorten labor, and decrease fetal heart rate abnormalities. – Not allowed if: bleeding, PROM (Premature Rupture of Membranes), or medical problems. • Back massage. • Deep breathing during contractions. • Analgesics as prescribed. • Leg cramps: dorsiflexion of the foot. Why: Anxiety and contractions cause sleeplessness.	تتوبه. . سريح. يقل الحاجة للمسكنات، ويقصر الولادة، ويقل اضطراب نبض الجنين. ر للميه ((PROM، أو مشاكل طبية. هري للقدم ((Dorsiflexion.
14	Posture of the woman in labor • Let her take any comfortable position except dorsal recumbent (flat on her back). • Encourage walking if not in active labor, and lying down toward the end of stage 1. Why: Lying flat can cause supine hypotension and lead to fetal distress.	استلقاء على الظهر ((Dorsal recumbent). النشط، وتستلقي في آخر المرحلة الأولى. سبط ((Supine hypotension وضيق للجنين.

#	Step & explanation	
15	Care of the bladder Encourage her to pass urine every 2–3 hours . Why: A full bladder causes poor uterine contractions and problems after delivery.	سبب مشاكل بعد الولادة.
16	Observe signs of maternal distress • Pulse over 100 b/min • Temperature over 38 °C • Decreased blood pressure • Sweating and pale face • Signs of dehydration • Dark vomit • Ketone bodies in urine • Irritability and restlessness • Anxiety and depression	
17	Observe for complications: the 3 P's • Power: weak (hypotonic) or too strong (hypertonic) uterine contractions. • Passenger: big baby, mal-position, malpresentation. • Passages: cephalopelvic disproportion (CPD), contracted pelvis, rigid cervix.	Hypotonic)) أو شديدة جداً ((Hypertonic). ر، وضع غير طبيعي، تقديم غير طبيعي. بين الرأس والحوض ((CPD، حوض ضيق، عنق رحم متصلب.

#	Step & explanation	الخطوة والشرح
18	Monitor and record the fetal heart rate (FHR) - Listen every 2 hours until the membranes rupture. - After rupture: every 30 minutes. Why: To recognize fetal distress or abnormalities early.	تابع وسجل نبض الجنين (FHR) - اسمعه كل ساعتين لحد ما الأغشية تنفتح. - بعد فتح الأغشية: كل 30 دقيقة. ليه؟ علشان نكتشف ضيق الجنين بدري.
19	Observe and record signs of fetal distress Excessive fetal movement Excessive moulding of the fetal head Excessive caput succedaneum (scalp swelling) - FHR more than 160 or less than 100 b/min, or irregular Meconium passage in a cephalic presentation	لاحظ وسجل علامات ضيق الجنين - حركة جنين زائدة - تشكل زائد في رأس الجنين ((Moulding - ورم فروة الرأس زائد ((Caput succedaneum - نبض الجنين أكثر من 160 أو أقل من 100 أو غير منتظم - نزول العقي ((Meconium في التقديم الرأسي

Finishing

إنهاء الإجراء

20	Record everything on the partogram Write all results and findings of each procedure.	سجل كل حاجة في الـ Partogram اكتب كل نتائج وملاحظات كل إجراء (الـ Partogram = رسم بياني لمتابعة الولادة).
21	Report any maternal or fetal complication.	بلّغ عن أي مضاعفات للأم أو الجنين.
22	Remove the equipment and wash hands.	شيل الأدوات واغسل إيديك.
23	Transfer the woman to the delivery room • Primipara: when the presenting part is bulging the perineum. • Multipara: when the cervix is 8–9 cm dilated.	انقل الست لغرفة الولادة • Primipara (أول ولادة): لما الجزء المقدم يبرز العجان. • Multipara (ولادة متكررة): لما عنق الرحم يوصل 8–9 سم.

4. Perineal Care

4. العناية بالعجان

Definition

Perineum = the area between the **bottom of the vagina** and the **top of the anus**. It goes through a lot of stress during pregnancy and delivery, so it needs special care.

Perineal care = cleaning the genitalia and the area around it: **lower abdomen, thighs down to the knee, and buttocks**.

تحت الشرج. يتعرض لضغط كبير في الحمل والولادة فمحتاج عناية

البطن، الفخذين لحد الركبة، والمؤخرة.

Purpose

- Keep the area **clean and comfortable**
- Remove **secretions and discharge**
- Reduce **irritation and bad odor**
- **Promote healing** of the suture line
- **Teach self-care** and genital hygiene
- **Detect abnormalities early**
- **Record** the condition of the area

Indications (when?)	
• On admission • Before and after vaginal examination • Before and after delivery • Before catheterization	

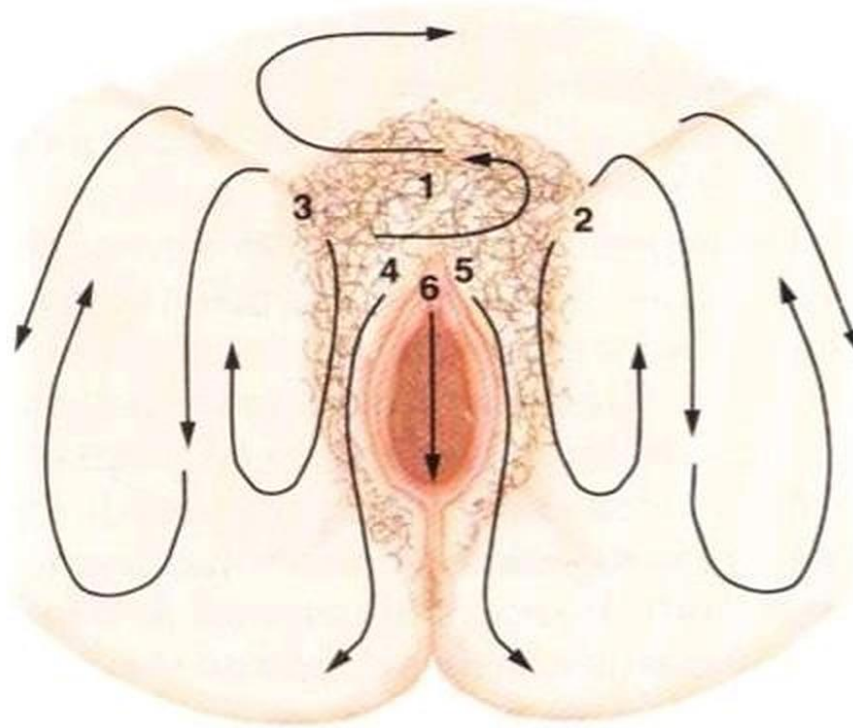
Equipment	
• Antiseptic solution • Sterile gloves • Kidney basin • Cotton sponges • Mackintosh (waterproof sheet) • Disposable waterproof sheets • Sterile pad • Bed pan • Paper bag • Wash cloths • Towels	

Perineal care steps

خطوات العناية بالعجان

#	Step & explanation	
1	Greet the woman , explain the procedure and get her consent . Why: Information builds cooperation and helps her relax.	
2	Wash hands and wear gloves . Why: To prevent spread of infection.	
3	Prepare the equipment and bring it to the bedside table. Why: For accurate performance and to save time.	
4	Ask her to empty her bladder (toilet, bed pan, or temporary catheterization). Why: So she is comfortable during the procedure.	
5	Close the door and draw the bed curtain . Why: To keep her privacy.	
6	Raise the bed to a comfortable height and remove or lower the side rail on your side. Why: Good positioning prevents back strain (body mechanics).	
7	Place the mackintosh under her hips . Why: Keeps the bed dry and clean.	
8	Place her in dorsal recumbent position : knees slightly bent, legs apart, pillow under the head . Why: This position gives easy access to the genitalia.	أركب مثنبة شوية والرجلين مفتوحين، ومخدة تحت راسها.
9	Uncover the perineal area from the umbilicus to the knees ("cover down, gown up"). Avoid exposing any unnecessary area. Why: To keep her privacy.	("). متكشفش أي منطقة مش لازمة.

#	Step & explanation	
10	Remove the soiled perineal pad carefully from front to back, away from the vulva.	
11	Roll the soiled pad inside with your gloves and discard it (paper bag). Wash hands, let them dry, and put on new gloves. Why: To prevent spread of infection.	شفها والبس جوانتي جديد.
12	Wash the perineum gently, using one clean folded wash cloth, one fold for each stroke. Follow the order (numbers on the picture): 1) Start with the mons pubis: from the level of the clitoris upward to the lower abdomen, in a zigzag motion. 2) Farther thigh (inner side): from inside to outside toward the knee, zigzag. 3) Nearer thigh: same way. 4) Groin: from top to bottom, farther side then nearer side. 5) Labia majora: farther then nearer. 6) Vestibule and labia minora: with a cotton sponge, top to bottom toward the anus, then outward. Why: Always clean from the cleanest area to the dirtiest (front to back) so germs from the anus never reach the vagina or urethra.	ة لكل مسحة. اتبع الترتيب (الأرقام في الصورة): سفل البطن بحركة متعرجة ((Zigzag). رجة. ج، وبعدين للخارج. توصلش للمهبل ولا مجرى البول.



Direction of cleaning: follow numbers 1 to 6
 اتجاه التنظيف: اتبع الأرقام من 1 لـ 6

13	Let the area dry. Why: Retained moisture harbors microorganisms.	
----	--	--

14	Turn the woman onto her side away from you (neck–knee technique: support her shoulder and knee as she turns). Why: This lets you clean the buttocks and thighs.	الرقبة والركبة: ادم كتفها وركبتها وهي بتلف).
15	Clean the buttocks and anal area from front to back (vulva toward anus), using a new fold each time. Why: Prevents moving germs from the anus to the vagina.	را (من الفرج ناحية الشرج) وبطية جديدة كل مرة.
16	Let it dry. If using antiseptic (Betadine), keep it in contact for 2–5 minutes. Why: Antiseptic needs contact time to kill germs.	(سببه 2–5 دقائق.
17	Apply a clean sterile pad if indicated, and return the woman to her back.	ع الست على ظهرها.
18	Remove supplies and clean the equipment. Why: Keeps the place clean and prevents spread of infection.	
19	Remove gloves and wash hands.	

20	Help her adjust her clothes and get into a comfortable position.	
21	Record the findings accurately in her file and report any abnormality.	ي حاجة مش طبيعية.

Note: the original lecture skips some step numbers (e.g. cleaning the buttocks and applying the pad). They are written here in the standard order so no step is missing.

ملحوظة: المحاضرة الأصلية مرقماها بنقص في بعض الخطوات (زي تنظيف المؤخرة ووضع الفوطة). كتبتهم هنا بالترتيب المعتاد علشان مفيش خطوة تضيع.

5. Exam Summary

5. ملخص الامتحان

#	If you see... / لو شفت	اربطها بـ / Remember...
1	First stage of labor المرحلة الأولى	Starts with true labor pain, ends at full dilation 10 cm; longest stage; 3 phases لطول مرحلة؛ 3 أطوار
2	Latent phase الطور الكامن	0–3 cm; 6–8 h (primi), 3–5 h (multi); mild, 15–30 sec, every 5–10 min (متكررة)؛ خفيف 15–30 ثانية
3	Active phase الطور النشط	4–7 cm; 3–5 h (primi), 1–2 h (multi); moderate-strong, 30–60 sec, every 3–5 min وسط-قوي 30–60 ثانية
4	Transition phase الطور الانتقالي	8–10 cm; 1–2 h (primi), under 1 h (multi); severe, 60–90 sec, every 2–3 min; hardest بديد 60–90 ثانية؛ الأصعب والأقصر
5	Primipara / Multipara أول ولادة / ولادة متكررة	Primipara = first birth; Multipara = more than once. Primipara labor is longer ولادة بتأخذ وقت أطول
6	Time to rate contractions تقييم الانقباضات	Frequency, intensity, duration within 10 min, every 30 min دقيقة
7	Show علامة الـ Show	Blood-stained mucus discharge
8	Membranes / gush of fluid نزول الميّه	Smell tissue to exclude urine; if ruptured, record the time ت
9	Frequent micturition كثرة التبول	Due to engagement: presenting part presses bladder على المثانة
10	Vital signs timing قياس العلامات الحيوية	Between contractions

#	If you see... / لو شفت	اربطها بـ / Remember...
11	P.V. exam assesses الفحص المهبلّي بيقمّ	Dilatation, effacement, station, moulding, engagement ، الانطباق
12	Station مستوى الرأس ((Station))	Fetal head level relative to ischial spines is
13	Routine tests التحاليل الروتينية	Urine (protein, glucose, pus, salts); blood (Hb, RBCs, ABO, Rh); blood glucose ABO ، RBCs ، (Rh)؛ سكر
14	Fluids in early labor السوائل أول الطلق	75 mL/hour + biscuits; I.V. if vomiting, ketosis, dehydration, anaesthesia توتونات أو جفاف أو تخدير
15	Why avoid solid food? ليه ممنوع الأكل الصلب؟	Gastric emptying delayed: aspiration risk during anaesthesia تخدير
16	Ambulation contraindications ممنوعات المشي	Bleeding, PROM, medical problems
17	Leg cramps تقلص الرجل	Dorsiflexion of the foot
18	Posture الوضع	Avoid dorsal recumbent: supine hypotension and fetal distress ق الجنين
19	Care of bladder العناية بالمثانة	Pass urine every 2–3 hours
20	Maternal distress إجهاد الأم	Pulse over 100, temp over 38 °C, low BP, pale, sweating, dehydration, dark vomit, k ، شحوب، عرق، جفاف، قيء داكن، كيتونات
21	3 P's الـ 3 P	Power (contractions), Passenger (fetus), Passages (pelvis/cervix) الممر Pass

#	If you see... / لو شفت	اربطها بـ / Remember...
22	FHR timing مواعيد نبض الجنين	Every 2 hours until rupture of membranes, then every 30 minutes توقيت
23	Fetal distress signs علامات ضيق الجنين	FHR over 160 or under 100 or irregular; excessive movement, moulding, caput; meconium حركة وتشكل و caput زائدين؛ عقي في الرأس
24	Partogram رسم متابعة الولادة	Record all findings of the labor
25	Transfer to delivery room النقل لغرفة الولادة	Primi: presenting part bulging perineum; Multi: cervix 8–9 cm تق الرحم 8–9 سم
26	Perineum العجان	Area between bottom of vagina and top of anus
27	Perineal care area منطقة العناية بالعجان	Genitalia, lower abdomen, thighs to knee, buttocks المؤخرة
28	Perineal care indications متى نعمل العناية بالعجان	Admission; before and after P.V. exam; before and after delivery; before catheterization بعد الولادة؛ قبل القسطرة
29	Perineal care position وضع العناية بالعجان	Dorsal recumbent, knees bent, legs apart, pillow under head ورحبن، مخدة تحت الرأس
30	Cleaning direction اتجاه التنظيف	Front to back; one fold of cloth per stroke; clean to dirty من نظيف إلى قذر
31	Why let the area dry? ليه نسيبها نتشف؟	Retained moisture harbors microorganisms
32	Betadine البيتادين	Keep contact 2–5 minutes

#	If you see... / لو شفت	Remember... / اربطها بـ
33	Cover down, gown up الغطا لتحت والجلابية لفوق	Uncover umbilicus to knees only: privacy